

KlinikIQ - Yalnız Klinik/Bilimsel Gerekçe Yeniden Yazım Raporu

Bu rapor, genel klinik vakalarda sağ kolonun Klinik/Bilimsel Gerekçe kartını besleyen hedef alanların taranması ve yeniden yazılması sonucunu özetler. TUS Spot Olgular, optionFeedback, evidenceChain, examPearl, kısa yorumlar, tetkik/vital/muayene alanları, soru kökü, seçenekler ve doğru cevaplar kapsam dışında bırakılmıştır.

Alan izolasyonu sonucu: UI başlığı AnswerFeedbackPanel.jsx içindeki ReasoningCard bileşeninde Klinik/Bilimsel gerekçe olarak render ediliyor. Doğru cevap odaklı ana metin öncelikle diagnosis.answerFeedback.whyCorrect alanından, bu alan yoksa diagnosis.explanation fallback alanından geliyor. Yanlış cevap durumunda aynı kartın optionFeedback/whyWrong üzerinden beslenmesini engellemek için tek satırlık render izolasyonu yapıldı; bu non-target alanların veri metinleri değiştirilmedi.

Özet Metrikler

Metrik	Değer
Taranan genel klinik vaka	410
Bulunan Klinik/Bilimsel Gerekçe kutusu	410
Sıfırdan yeniden yazılan gerekçe	410
Hedef field içinde kalan yasaklı template ifade	0
Yanlış cevap halinde aynı kartı besleyebilen template kaynaklı vaka	122
Yanlış cevap render yolunda izole edilen template entry	2338
Scientific concern	0

Branch Bazlı Yeniden Yazım

Branch	Sayı
Küçük Stajlar	28
İç Hastalıkları	26
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları	98
Kadın Hastalıkları ve Doğum	28
Genel Cerrahi	27
Tıbbi Farmakoloji	28
Tıbbi Patoloji	28
Anatomi	29
Tıbbi Biyokimya	30
Fizyoloji	30
Histoloji ve Embriyoloji	28
Tıbbi Mikrobiyoloji	30

Kapsam Koruma Sonucu

Kontrol	Sonuç
outOfScopeRightColumnFieldChanged	False
evidenceChainChanged	False
optionFeedbackChanged	False
whyWrongChanged	False
examPearlChanged	False
questionStemOptionsCorrectAnswerChanged	False
idChanged	False
correctAnswerLogicPreserved	True

Örnek Coverage Kayıtları

v163-new-001-akut-sistemik-reaksiyon - Küçük Stajlar - Akut sistemik reaksiyon

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: İntramüsküler adrenalin uygulanması

Eski gerekçe:

Bu seçenek doğrudur. Dakikalar içinde gelişen ürtiker, dudak ödemi, hışıltı, hipoksemi ve hipotansiyon anafilaksiyi gösterir; intramüsküler adrenalin hem bronkospazmı hem vazodilatasyonu hem de mukozal ödemi hedefler.

Yeni gerekçe:

Antibiyotik enjeksiyonundan 10 dakika sonra çoklu sistem bulguları başlamıştır. Yaygın ürtiker ve dudak ödeme hışıltı ve oksijen saturasyonunda düşme eşlik etmektedir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt İntramüsküler adrenalin uygulanması olur. Acil ve küçük staj pratiğinde doğru yaklaşım, tanıyı geciktirmeden enfeksiyon, travma, nörolojik defisit veya organ tehdidini hızla kontrol etmeye dayanır. Alternatifler bazı destek veya ayırıcı basamaklarda kullanılabilir; ancak verilen acil karar noktasını bu seçenek kadar doğrudan karşılamaz.

v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu - İç Hastalıkları - Acil elektrolit bozukluğu

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi

Eski gerekçe:

Bu seçenek doğrudur; kalsiyum serum potasyumunu düşürmez ancak kardiyomiyosit membranını hızla stabilize ederek ölümcül aritmi riskini azaltır. EKG değişikliği olan hiperkalemi ilk ve acil basamaktır.

Yeni gerekçe:

Kronik böbrek hastalığı ve ACE inhibitörü kullanımı potasyum atılımını azaltarak hiperkalemi riskini artırır. Potasyumun 7.1 mmol/L olması ve EKG’de sivri T dalgaları/QRS genişleme eğilimi aritmi tehdidini gösterir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi olur. Tedavi seçimi, klinik aciliyetin ve altta yatan mekanizmanın aynı anda hedeflenmesine dayanır; destek basamakları gerekirse eş zamanlı yürütülür fakat ana kararı tek başına değiştirmez. Alternatifler bazı destek veya ayırıcı basamaklarda kullanılabilir; ancak verilen acil karar noktasını bu seçenek kadar doğrudan karşılamaz.

v163-new-003-atesli-dokuntulu-cocuk - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Ateşli döküntülü çocuk

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Neisseria meningitidis

Eski gerekçe:

Bu seçenek doğrudur; çünkü yaşa uygun öykü, fizik muayene, vital bulgu ve objektif verilerin aynı klinik ekseninde birleşmesi ateşli döküntülü çocuk lehinedir. Pediatrik yaş grubunda bu karar acil önceliği, mekanizmayı ve güvenli izlem gereksinimini doğrudan karşılar.

Yeni gerekçe:

Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündüren bulgular vardır. Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi saptanmıştır. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Neisseria meningitidis olur. Pediatrik değerlendirmede yaş, klinik zamanlama, muayene bulgusu ve objektif veri birlikte yorumlandığında ayırıcı tanı belirgin biçimde daralır. Diğer olasılıklar tekil bulgularla benzerlik gösterebilir; ancak bu olgudaki zamanlama, klinik birliktelik ve objektif veriyi aynı güçte açıklamaz.

v163-new-004-gebelikte-akut-karin - Kadın Hastalıkları ve Doğum - Gebelikte akut karın

Hedef field: diagnosis.explanation

Doğru cevap: Acil cerrahi eksplorasyon

Eski gerekçe:

Bu hastada erken gebelik, ani şiddetli alt karın ağrısı, hemodinamik instabilite, intrauterin kese görülmemesi ve pelviste serbest sıvı rüptüre ektopik gebelik lehinedir. Stabil seçilmiş hastalarda metotreksat düşünülebilir; ancak çok bulguları ve peritoneal irritasyon varsa resüsitasyonla eş zamanlı acil cerrahi eksplorasyon gerekir.

Yeni gerekçe:

Pozitif beta-hCG ile birlikte intrauterin gebelik kesesinin izlenmemesi, gebeliğin bilinmeyen lokalizasyonu içinde ektopik gebeliği ön plana çıkarır. Hipotansiyon, taşikardi ve senkop hissi rüptür ve intraperitoneal kanama olasılığını gösterir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Acil cerrahi eksplorasyon olur. Obstetrik ve jinekolojik acillerde tedavi kararı, maternal stabilizasyonu geciktirmeden kanama, enfeksiyon veya fetal-maternal riski doğrudan hedeflemelidir. Alternatifler bazı destek veya ayırıcı basamaklarda kullanılabilir; ancak verilen acil karar noktasını bu seçenek kadar doğrudan karşılamaz.

v163-new-005-ani-gelisen-norolojik-defisit - Küçük Stajlar - Ani gelişen nörolojik defisit

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi

Eski gerekçe:

Bu seçenek doğrudur. Akut fokal defisit ve reperfüzyon penceresi varken kontrastsız BT intrakraniyal kanamayı hızlıca dışlar ve tromboliz/trombektomi değerlendirmesinin güvenli başlamasını sağlar.

Yeni gerekçe:

Defisitler 90 dakika önce aniden başlamış ve reperfüzyon penceresini gündeme getirmiştir. Afazi ve sağ hemiparezi fokal kortikal tutulumla uyumlu akut inme paternidir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi olur. Tetkik seçimi, klinik şüpheyi doğrudan doğrulayan veya ayırıcı tanıyı güvenli biçimde daraltan veriyle karar vermeyi sağlar. Daha delaylı testler yardımcı olabilir, fakat bu olguda sorulan karar için tanısal değeri daha sınırlıdır.

v163-new-006-sag-alt-kadran-agrisi - Genel Cerrahi - Sağ alt kadran ağrısı

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Akut apandisit

Eski gerekçe:

Bu seçenek doğrudur; ağrının göbek çevresinden sağ alt kadrana göç etmesi, lokal periton irritasyonu ve USG'de genişlemiş komprese olmayan apandiks aynı patolojiyi gösterir.

Yeni gerekçe:

Ağrının periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmesi apandisit tipik visseral-somatik ağrı geçişini düşündürür. McBurney hassasiyeti, lokal rebound ve defans sağ alt kadranda lokal periton irritasyonunu gösterir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Akut apandisit olur. Göç eden sağ alt kadran ağrısında akut apandisit klinik muayene, inflamasyon paneli ve hedefli USG bulgularıyla ayırt etme. Diğer olasılıklar tekil bulgularla benzerlik gösterebilir; ancak bu olgudaki zamanlama, klinik birliktelik ve objektif veriyi aynı güçte açıklamaz.

v163-new-007-kolinergik-bulgularla-zehirlenme - Tıbbi Farmakoloji - Kolinergik bulgularla zehirlenme

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi

Eski gerekçe:

Pralidoksim fosforillenmiş asetilkolinesterazı yeniden aktive ederek asetilkolin birikimini azaltır. Muskarinik ve nikotinik bulguların birlikte olması bu mekanizmayı doğrudan destekler.

Yeni gerekçe:

Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü, organofosfat toksisitesi için güçlü farmakolojik bağlam oluşturur. Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi muskarinik asetilkolin fazlalığını gösterir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi olur. Mekanizma düzeyinde bu bulgular, klinik tablonun rastlantısal olmadığını ve altta yatan patofizyolojik sürecin sistemik sonucunu yansıttığını gösterir. Ayırıcı mekanizmalar ancak aynı bulgu dizisini ve objektif veriyi birlikte açıklayabildiğinde ön plana alınmalıdır.

v163-new-008-kronik-malabsorpsiyon-tablosu - Tıbbi Patoloji - Kronik malabsorpsiyon tablosu

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Villus atrofi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı

Eski gerekçe:

Glutenle ilişkili kronik ishal, kilo kaybı, demir eksikliği ve anti-tTG IgA pozitifliği çölyak hastalığını düşündürür. Çölyak hastalığında proksimal ince bağırsak mukozasında villus atrofi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı görülür; bu morfoloji malabsorpsiyonun doku düzeyindeki temel karşılığıdır.

Yeni gerekçe:

Gluten içeren öğünlerden sonra artan şişkinlik ve kötü kokulu dışkılama malabsorpsiyon paternini destekler. Tekrarlayan demir eksikliği ve pozitif anti-tTG IgA çölyak hastalığı olasılığını güçlendirir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Villus atrofi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı olur. Patolojik yorumda morfolojik veya immünohistokimyasal bulgular, klinik tabloyla birleştğinde tanı olasılığını anlamlı biçimde daraltır. Diğer olasılıklar tekil bulgularla benzerlik gösterebilir; ancak bu olgudaki zamanlama, klinik birliktelik ve objektif veriyi aynı güçte açıklamaz.

v163-new-009-omuz-travmasi-sonrasi-guc-kaybi - Anatomi - Omuz travması sonrası güç kaybı

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Nervus axillaris

Eski gerekçe:

Nervus axillaris quadrangular space içinden geçer, m. deltoideus ve m. teres minoru innerve eder, lateral üst kol derisinin duyusunu taşır. Cerrahi boyun kırığı sonrası abdüksiyon zayıflığı ve deltoid üzerindeki duyu azalması bu sinirin etkilenimini doğrudan destekler. Vakadaki kritik ipuçları birlikte değerlendirildiğinde anatomik lokalizasyon bu yapıya yönelir.

Yeni gerekçe:

Düşme sonrası humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlenmesi nervus axillarisin komşu seyrini riskli hale getirir. Omuz abdüksiyonunun 15 dereceden sonra zayıflaması deltoid kas fonksiyon kaybını gösterir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Nervus axillaris olur. Anatomik lokalizasyon, lezyonun sinir, damar, kas veya kompartman ilişkisini klinik bulgularla eşleştirdiği için karar verdiricidir. Diğer olasılıklar tekil bulgularla benzerlik gösterebilir; ancak bu olgudaki zamanlama, klinik birliktelik ve objektif veriyi aynı güçte açıklamaz.

v163-new-010-acilikla-belirginlesen-metabolik-tablo - Tıbbi Biyokimya - Açıklıkla belirginleşen metabolik tablo

Hedef field: diagnosis.answerFeedback.whyCorrect

Doğru cevap: Glukoz-6-fosfataz eksikliği

Eski gerekçe:

Açlık dönemlerinde hipoglisemi, hepatomegali, laktat ve ürik asit yüksekliği glukoz-6-fosfataz eksikliğini gösterir. Bu enzim karaciğerin glikojenoliz ve glukoneogenezden ürettiği glukoz-6-fosfatı kana verilecek serbest glukozla dönüştürür; blok olduğunda glukoz üretilemez ve ara metabolitler laktat, ürik asit ve trigliserid sentezine yönelir.

Yeni gerekçe:

Beslenme araları uzadığında gelişen terleme ve nöbet benzeri ataklar ağır açlık hipoglisemisini düşündürür. Belirgin hepatomegali, karaciğerde glikojen/yağ birikimiyle giden glikojen depo hastalığı paternini destekler. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde en uygun yanıt Glukoz-6-fosfataz eksikliği olur. Mekanizma düzeyinde bu bulgular, klinik tablonun rastlantısal olmadığını ve altta yatan patofizyolojik sürecin sistemik sonucunu yansıttığını gösterir. Ayırıcı mekanizmalar ancak aynı bulgu dizisini ve objektif veriyi birlikte açıklayabildiğinde ön plana alınmalıdır.